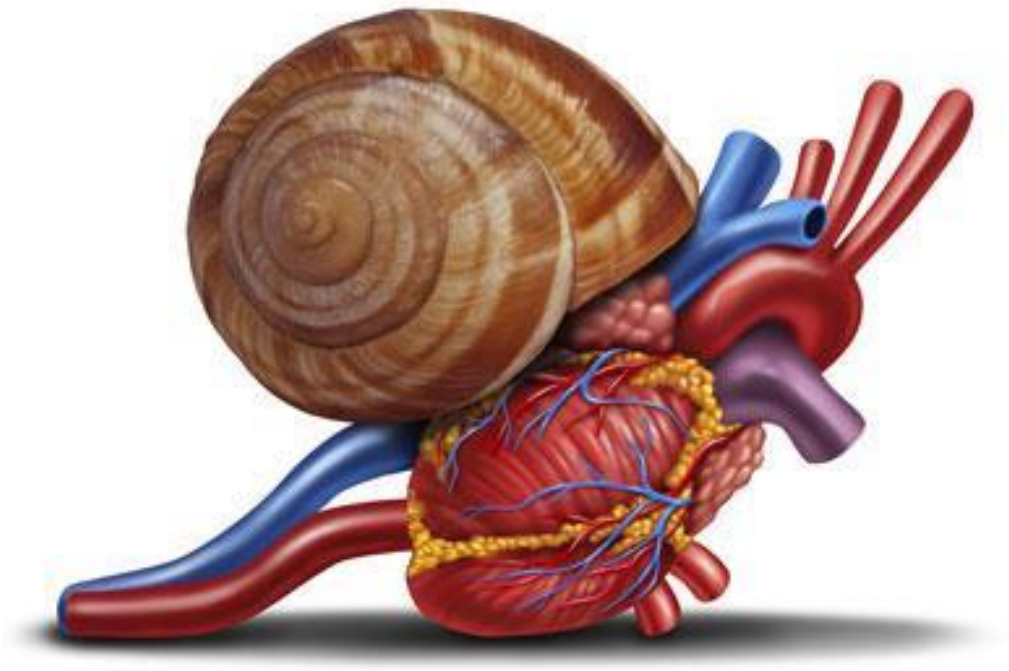
Sémiologie de l’insuffisance cardiaque

Dr Benchaoulia – CHU d’Oran



Plan

- Définition
- Physiopathologie
- Classification
- Signes fonctionnels
- Signes physiques
- Œdème aigu du poumon (OAP)
- Synthèse : IC gauche et IC droite

Définition

- Syndrome clinique : **symptômes** (dyspnée, fatigue) ± **signes** (œdèmes, râles)
- Due à une anomalie cardiaque structurelle et/ou fonctionnelle
- Incapacité du cœur à couvrir les besoins hémodynamiques de l'organisme : d'abord **à l'effort**, puis **au repos**

Physiopathologie (1/2)

- **En amont** : augmentation des pressions de remplissage = **congestion**
  - pulmonaire (IC gauche)
  - veineuse systémique (IC droite)
- **En aval** : baisse du débit cardiaque
  - diminution du transport d'oxygène
  - hypoperfusion tissulaire et viscérale

Physiopathologie (2/2)

- **Mécanismes d'adaptation** :
  - hypertrophie et dilatation du ventricule
  - activation neuro-hormonale (système sympathique, SRAA)
  - rétention hydrosodée
- Utiles au début, ils deviennent **délétères** : ils aggravent la congestion et le remodelage

Classification

- **IC gauche** : congestion pulmonaire
- **IC droite** : congestion veineuse systémique
- **IC globale** : association des deux

Insuffisance cardiaque gauche

- Deux types :
- **IC systolique** : atteinte de la fonction contractile du VG
- **IC diastolique** : trouble du remplissage du VG (hypertrophie ventriculaire), fonction contractile conservée

Classification selon la FEVG

- **FEVG ≤ 40 %** : IC à FEVG réduite
- **FEVG ≥ 40 %** : IC à FEVG préservée

Signes fonctionnels : la dyspnée

- **Dyspnée** : difficulté respiratoire (essoufflement)
- Signe majeur de l'IC gauche, précoce à l'effort
- Évaluer l'intensité avec la classification **NYHA** (New York Heart Association), la plus utilisée

Classification NYHA

- **Stade I** : efforts importants inhabituels ; aucune gêne dans la vie courante
- **Stade II** : efforts importants habituels (marche rapide, en côte, escaliers > 2 étages)
- **Stade III** : efforts peu intenses de la vie courante (marche en terrain plat, escaliers ≤ 2 étages)
- **Stade IV** : dyspnée permanente de repos ou efforts minimes (enfiler un vêtement)

Types de dyspnée (1/2)

- **Dyspnée d'effort** : la plus précoce, polypnée superficielle ; la quantifier (nombre d'étages)
- **Orthopnée** : dyspnée de décubitus, soulagée par la position assise ; la quantifier (nombre d'oreillers)
- **Dyspnée paroxystique nocturne** : réveil brutal la nuit avec oppression, soulagé en position assise

Types de dyspnée (2/2)

- **Dyspnée permanente** ou de repos : forme sévère
- **Asthme cardiaque** : dyspnée expiratoire avec sibilants diffus
- **Dyspnée aiguë** dans le cadre d'un **OAP**
- **Cheyne-Stokes** : IC sévère ; respiration croissante puis décroissante, pause de quelques secondes, puis le cycle reprend

Autres signes de l'IC gauche

- **Toux** sèche, d'effort ou nocturne
- **Hémoptysie** : isolée ou secondaire à un OAP
- **Asthénie**, nycturie, oligurie

Douleur thoracique (angor)

- Signe de la **cardiopathie ischémique** (cause ou comorbidité)
- Effort : circonstance d'apparition habituelle
- Siège rétrosternal, irradiant au membre supérieur gauche et à la mâchoire
- Constrictive, « en étau »
- Brève, calmée par le repos et la trinitrine

Palpitations, syncope

- **Palpitation** : perception anormale des battements du cœur (tachycardie, trouble du rythme)
- **Syncope** : perte de connaissance brève, complète et brutale (anoxie cérébrale)
- **Lipothymie** : perte de connaissance incomplète, avec signes prémonitoires (troubles visuels, bourdonnements d'oreilles, sueurs) : début progressif

Signes fonctionnels de l'IC droite

- **Hépatalgie d'effort**
- **Troubles digestifs** : anorexie, nausées, ballonnement
- **Prise de poids** et œdèmes des membres inférieurs
- Oligurie, asthénie

Signes physiques

- **4 temps** : inspection, palpation, percussion, auscultation
- Examen général : pression artérielle, pouls, fréquence respiratoire, poids

Inspection

- Déformation thoracique, polypnée, orthopnée
- Cyanose des extrémités, marbrures
- **Turgescence jugulaire** spontanée
- **Œdèmes des membres inférieurs** : blancs, mous, indolores, prenant le godet, déclives
- Ascite, ictère dans les formes sévères

Œdème prenant le godet



Œdème blanc, mou, indolore, déclive

Hippocratisme digital



Non spécifique de l'IC : cardiopathie cyanogène, endocardite, pathologie pulmonaire

Palpation (1/2)

- **Choc de pointe** : 4e à 5e espace intercostal gauche, ligne médio-claviculaire ; soulèvement systolique synchrone du pouls
- Dévié en bas et à gauche ou **étalé** si cardiomégalie (IC globale)

Palpation (2/2)

- **Signe de Harzer** : battements du VD hypertrophié ou dilaté ; pouce dans l'angle xypho-costal gauche, en inspiration profonde
- **Hépatomégalie** : lisse, ferme, douloureuse, avec **reflux hépato-jugulaire**

Signe de Harzer



Battements du VD sous l’appendice xiphoïde

Percussion

- Matité des bases pulmonaires : épanchement pleural
- Matité déclive des flancs : ascite

Auscultation cardiaque (1/2)

- **Tachycardie**
- **Galop gauche** : à la pointe, proto-diastolique (B3) ou présystolique (B4) = insuffisance ventriculaire gauche
- **Galop droit** : à la base de l'appendice xiphoïde = insuffisance ventriculaire droite

Auscultation (2/2)

- **Souffle d'insuffisance tricuspidienne** : majoré par l'inspiration profonde = **signe de Carvallo**
- **Éclat de B2** au foyer pulmonaire (HTAP)
- **Râles crépitants** bilatéraux aux bases (congestion pulmonaire)

Œdème aigu du poumon (OAP)

- Dyspnée aiguë, orthopnée, sueurs, anxiété
- Expectoration mousseuse, rosée, hémoptoïque
- Râles crépitants bilatéraux, « en marée montante »
- **Signes de gravité** : polypnée > 30/min ou bradypnée, cyanose, marbrures, troubles de la conscience, PA systolique < 90 mmHg

Synthèse : IC gauche et IC droite

IC gauche	IC droite
Dyspnée, orthopnée	Hépatalgie d'effort
Toux, hémoptysie	Œdèmes déclives
Crépitants bilatéraux	Turgescence jugulaire
Galop gauche (pointe)	Galop droit (xiphoïde)
Tachycardie	Reflux hépato-jugulaire

IC droite et gauche

Gauches		Droits	
	Dyspnée		Turgescence jugulaire
	Tachycardie		Reflux hépato-jugulaire
	Crépitants pulmonaires bilatéraux		Oedème des membres inférieurs

Points clés

- IC : syndrome clinique, d'abord à l'effort puis au repos
- **Dyspnée** = signe majeur ; la grader (NYHA)
- IC gauche : congestion **pulmonaire**
- IC droite : congestion **systémique**
- OAP : urgence vitale

Merci pour votre attention



Références

- McDonagh TA et al. Recommandations ESC 2021 sur l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique. Eur Heart J 2021 ; 42 : 3599-3726